

Le journal des symptômes et séquelles

Kit Erreur médicale LEXVOX, palier 1 (gratuit), document 1.3.

Ce que ce document va vous permettre - Consigner chaque jour, au bon format, vos douleurs, vos séquelles et leur retentissement sur votre vie quotidienne et professionnelle, pour que ces faits datés nourrissent plus tard l'évaluation de vos préjudices. - Disposer d'un modèle quotidien et d'une synthèse hebdomadaire prêts à remplir, simples à tenir même les jours difficiles. - Garder la trace, dans une section dédiée, des risques et des alternatives dont on ne vous avait pas parlé, au service du défaut d'information et du préjudice d'impréparation.

Avertissement. Ce kit est un outil d'information et de préparation. Il ne constitue pas une consultation juridique personnalisée et ne remplace pas l'analyse de votre situation par un avocat. En cas d'urgence médicale, appelez le 15. Ce kit ne donne aucun conseil médical.

Pourquoi tenir ce journal change votre dossier

Après un accident médical, votre mémoire s'use plus vite que vous ne le croyez. Les douleurs des premières semaines s'effacent dès qu'elles s'atténuent. Les nuits sans sommeil se confondent. Les gestes devenus impossibles finissent par sembler normaux, tant on s'y habitue. Or c'est précisément ce quotidien qui, le jour de l'expertise, servira à mesurer ce que vous avez subi.

L'évaluation de vos préjudices ne repose pas sur une impression générale. Elle repose sur des faits, situés dans le temps, décrits avec précision. Un expert qui vous examine plusieurs mois ou plusieurs années après les faits ne peut pas deviner l'intensité de vos douleurs passées. Il s'appuie sur les pièces médicales et sur ce que vous êtes capable de documenter. Un journal tenu jour après jour transforme votre vécu en preuve utilisable.

Cette réalité a un poids concret. Les offres spontanées des assureurs sont fréquemment 2 à 5 fois inférieures à l'indemnisation réelle obtenue avec un avocat spécialisé. L'écart se comble avec des éléments datés et vérifiables, pas avec des souvenirs. Votre journal est l'un de ces éléments, et c'est l'un des rares que vous maîtrisez entièrement.

Avant d'aller plus loin, un mot de vocabulaire. La **consolidation** est le moment où votre état de santé se stabilise, où les soins ne l'améliorent plus de façon notable. C'est à partir de cette date que se chiffre définitivement votre préjudice. Tout ce que vous consignez avant elle documente le chemin parcouru, et ce chemin compte autant que le point d'arrivée.

Les préjudices que votre journal vient nourrir

Les postes de préjudice corporel sont recensés par la nomenclature Dintilhac, un rapport de référence de juillet 2005 qui sert d'outil commun aux avocats, aux magistrats et aux médecins experts. Ce n'est pas une loi, mais c'est la grille que tout le monde utilise. Trois postes, en particulier, se nourrissent directement de ce que vous notez au quotidien.

Le **déficit fonctionnel temporaire**, souvent abrégé DFT, désigne la gêne dans les actes de la vie courante que vous subissez avant la consolidation, c'est-à-dire la réduction de votre autonomie, de vos capacités et de votre qualité de vie pendant la période de soins. Un mois passé alité, une main immobilisée, l'impossibilité de vous laver seul : tout cela relève du DFT. Il s'évalue en durée et en intensité, d'où l'intérêt de dater précisément le début et la fin de chaque gêne.

Les **souffrances endurées** désignent toutes les douleurs physiques et les souffrances psychiques que vous éprouvez depuis l'accident médical jusqu'à la consolidation. On les cote sur une échelle de 1 à 7 lors de l'expertise. Cette cotation gagne à s'appuyer sur une trace concrète : l'intensité de vos douleurs jour après jour, les traitements antalgiques, les réveils nocturnes, l'anxiété avant une nouvelle intervention. Un chiffre noté chaque soir vaut mieux qu'une estimation rétrospective.

Le **préjudice d'agrément** désigne l'impossibilité, ou la difficulté, de pratiquer régulièrement une activité de loisir ou de sport que vous exerciez avant l'accident médical. Il ne se présume pas : il faut établir que vous couriez, jardiniez, jouiez d'un instrument, et que vous ne

le pouvez plus, ou plus comme avant. Consigner les activités que vous avez dû abandonner, avec leur date d'arrêt, prépare la démonstration de ce poste.

À ces trois postes s'ajoute une dimension propre au contentieux médical. Le journal permet aussi de garder la mémoire de ce qu'on ne vous avait pas dit avant le geste, sujet auquel une section entière de ce document est consacrée plus bas. Sur ce terrain, la charge de la preuve pèse d'ailleurs sur le professionnel de santé. L'article L1111-2 du code de la santé publique consacre votre droit à l'information, et en cas de litige, c'est au médecin ou à l'établissement de prouver qu'il vous l'a bien délivrée.

Voici la citation exacte de l'article L1111-2 du code de la santé publique (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000054137408) :

« Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. »

Comment tenir ce journal, sans vous épuiser

Quelques règles simples suffisent à rendre votre journal solide.

Écrivez chaque jour, même brièvement. Trois lignes valent mieux qu'une page rédigée de mémoire une fois par mois. La régularité est ce qui donne de la valeur à l'ensemble. Un jour manqué n'est pas grave, mais reprenez dès le lendemain.

Restez factuel. Notez ce que vous ressentez et ce que vous ne pouvez pas faire, sans dramatiser ni minimiser. Un journal sincère, où alternent les bons et les mauvais jours, est plus crédible qu'un récit uniformément noir. Les jours où cela va mieux méritent aussi d'être notés : ils montrent que vous ne cherchez pas à exagérer.

Datez tout. Chaque entrée porte sa date. C'est la datation qui distingue une preuve d'une simple plainte.

Chiffrez ce qui peut l'être. Une douleur cotée de 0 à 10, une aide mesurée en minutes, un nombre de réveils nocturnes : ces chiffres, additionnés sur des semaines, dessinent une réalité qu'aucun mot seul ne rend.

Restez loyal. Ne notez que des faits vous concernant, dans un carnet qui est le vôtre. Ne cherchez jamais à enregistrer un soignant à son insu ni à fabriquer une preuve : un procédé déloyal se retourne contre la victime. Votre journal tire sa force de sa sincérité, pas d'un stratagème.

Conservez une copie. Photographiez ou scannez régulièrement vos pages, et rangez ces fichiers dans un dossier dédié. Un carnet perdu ne se reconstitue pas.

Le modèle quotidien à remplir

Reproduisez ce cadre chaque soir, sur un carnet papier ou dans une note numérique. Il se remplit en quelques minutes. L'important n'est pas la longueur, mais la constance et la précision des chiffres.

Journal du jour

Date : Jour de la semaine :

1. Douleur. Note globale de 0 (aucune douleur) à 10 (douleur maximale imaginable) : Localisation principale (où avez-vous mal aujourd'hui) : Moment le plus douloureux de la journée : Traitement antalgique pris (nom, nombre de prises) :

2. Sommeil. Nombre d'heures dormies : Nombre de réveils dans la nuit : Réveils liés à la douleur : oui / non. Qualité du sommeil de 0 (très mauvais) à 10 (excellent) :

3. Actes pénibles ou impossibles aujourd'hui. Cochez et précisez. ☐ Me laver, faire ma toilette. Précision : ☐ M'habiller seul. Précision : ☐ Préparer un repas, manger. Précision : ☐ Me déplacer dans le logement, monter un escalier. Précision : ☐ Sortir, faire une course, conduire. Précision : ☐ M'occuper de mes enfants ou d'un proche. Précision : ☐ Autre acte du quotidien :

4. Aide reçue aujourd'hui. Qui vous a aidé, pour quel geste, combien de temps. Personne : Tâche : Durée en minutes : Personne : Tâche : Durée en minutes : Total d'aide reçue dans la journée (en minutes) :

5. Moral. Note de 0 (très mauvais) à 10 (très bon) : En un mot ou deux, votre état d'esprit du jour : Anxiété liée à un rendez-vous ou à une intervention à venir : oui / non.

6. Activités que je n'ai pas pu faire aujourd'hui. Loisir, sport, sortie, engagement. Sur le plan de la vie personnelle et intime, le retentissement du jour, décrit avec pudeur et en vos propres mots (vous restez libre de n'écrire qu'une lettre ou un signe repère si vous préférez) :

Un mot sur la dernière ligne. Le retentissement sur la vie intime et affective est un préjudice réel et reconnu. Vous n'avez pas à entrer dans des détails qui vous mettent mal à l'aise. Une formulation sobre suffit, par exemple « intimité impossible ce jour » ou un simple repère que vous seul comprenez. Ce qui compte est la trace datée, pas la crudité du récit. Vous pourrez, le moment venu, en parler à votre avocat dans un cadre confidentiel.

Le modèle hebdomadaire de synthèse

Une fois par semaine, prenez cinq minutes pour relire vos sept fiches et en tirer une vue d'ensemble. Cette synthèse est précieuse : elle transforme une accumulation de détails en tendances lisibles, celles-là mêmes qu'un expert cherche à saisir.

Synthèse de la semaine

Semaine du au (numéro de semaine depuis l'accident médical :

Douleur. Note la plus basse de la semaine : Note la plus haute : Moyenne approximative :
Localisation la plus fréquente :

Sommeil. Nombre de nuits vraiment reposantes : Nombre de nuits difficiles : Total approximatif de réveils nocturnes sur la semaine :

Autonomie. Les trois actes du quotidien les plus difficiles cette semaine : 1. 2.
..... 3. Un acte que je peux à nouveau faire, s'il y a une
amélioration :

Aide humaine. Total d'aide reçue sur la semaine (additionnez les minutes des sept jours) : minutes.
Personnes qui vous ont aidé le plus souvent :

Moral. Tendance de la semaine : en amélioration / stable / en dégradation. Événement marquant, bon ou
mauvais :

Vie sociale, loisirs, travail. Activités ou engagements manqués cette semaine :
Répercussion sur votre activité professionnelle (arrêt, aménagement, fatigue au poste) :
.....

Rendez-vous et soins de la semaine. Consultations, examens, séances de rééducation :
..... Question restée sans réponse, à poser au prochain rendez-vous :
.....

Cette synthèse a un autre mérite. Le total hebdomadaire d'aide humaine, en minutes, prépare la démonstration du besoin d'aide d'une tierce personne, c'est-à-dire l'assistance d'un proche ou d'un professionnel pour les gestes que vous ne pouvez plus accomplir seul. Ce poste est souvent l'un des plus élevés d'un dossier, et il se prouve par des heures documentées, pas par une estimation faite après coup.

Section spécifique : les informations que l'on ne m'avait pas données

Cette section est propre au contentieux médical. Elle mérite une page à part dans votre carnet, car elle sert un terrain juridique distinct de vos douleurs : celui de l'information que vous auriez dû recevoir avant le geste, et que vous n'avez pas reçue.

Le raisonnement est le suivant. Avant une intervention ou un traitement, le professionnel de santé doit vous informer des risques fréquents ou graves normalement prévisibles, des alternatives possibles et des conséquences d'un refus. C'est l'exigence posée par l'article L1111-2 cité plus haut. Lorsque cette information manque et qu'un risque non annoncé se réalise, deux préjudices distincts peuvent naître.

Le premier est le **préjudice d'impréparation**, que l'on peut définir ainsi : c'est le préjudice moral subi par le patient qui, faute d'avoir été informé d'un risque, n'a pas pu s'y préparer psychologiquement lorsque ce risque s'est réalisé. La Cour de cassation en a fait un préjudice autonome, réparable en lui-même, indépendamment de toute perte de chance d'avoir évité l'acte.

Voici la citation exacte de l'arrêt de principe, Cour de cassation, 1^{re} chambre civile, 23 janvier 2014, pourvoi n° 12-22.123 (<https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028514413>) :

« le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, que le juge ne peut laisser sans réparation »

Cette solution a été confirmée depuis. La Cour de cassation, 1^{re} chambre civile, dans son arrêt du 25 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.898 (<https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033943617>), a rappelé qu'il s'agit d'« un préjudice moral résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, qui, dès lors qu'il est invoqué, doit être réparé ».

Le second terrain est celui du **défaut d'information** lui-même, ce manquement du professionnel à son obligation de vous renseigner. Puisque c'est à lui de prouver qu'il vous a informé, tout ce que vous consignez sur ce que vous ignoriez vient éclairer le débat. Vos notes ne remplacent pas cette preuve, mais elles fixent votre version des faits au plus près du moment où ils se sont produits.

D'où l'intérêt de tenir, à froid, la liste de ce dont on ne vous a jamais parlé. Remplissez le cadre ci-dessous dès que vous découvrez, souvent après coup, un risque ou une alternative dont personne ne vous avait informé.

Ce que l'on ne m'avait pas dit

Date à laquelle je l'ai découvert : Comment je l'ai appris (nouveau médecin, notice, dossier médical, proche) :

1. Le risque ou la complication qui s'est réalisé : M'en avait-on parlé avant le geste : oui / non / je ne m'en souviens pas. Un document d'information ou de consentement m'a-t-il été remis et signé : oui / non / je ne sais pas.

2. Les alternatives que l'on ne m'a pas proposées : (Autre traitement, autre technique, possibilité d'attendre, possibilité de refuser.)

3. Ce que j'aurais fait si j'avais su : (Décrire honnêtement : accepter quand même, demander un second avis, refuser, différer.)

4. Comment j'ai vécu la découverte que je n'avais pas été prévenu : (Le choc de l'impréparation, le sentiment de ne pas avoir choisi en connaissance de cause.)

Ne cherchez pas à qualifier juridiquement vous-même ces éléments. Contentez-vous de décrire ce que vous saviez, ce que vous ne saviez pas, et à quel moment vous l'avez appris. Le tri entre défaut d'information, préjudice d'impréparation et éventuelle perte de chance relève de l'analyse de votre avocat, à partir de la matière que vous aurez rassemblée.

Un petit lexique pour ce document

- **Consolidation** : moment où votre état de santé se stabilise et où les soins ne l'améliorent plus de façon notable ; point de départ du chiffrage définitif.

- **Déficit fonctionnel temporaire (DFT)** : gêne dans les actes de la vie courante subie avant la consolidation, évaluée en durée et en intensité.
- **Souffrances endurées** : douleurs physiques et souffrances psychiques éprouvées de l'accident médical jusqu'à la consolidation, cotées de 1 à 7.
- **Préjudice d'agrément** : impossibilité ou difficulté de pratiquer régulièrement une activité de loisir ou de sport exercée avant l'accident médical.
- **Tierce personne** : aide d'un proche ou d'un professionnel pour les gestes que vous ne pouvez plus accomplir seul.
- **Défaut d'information** : manquement du professionnel de santé à son obligation de vous informer des risques, des alternatives et des conséquences d'un refus.
- **Préjudice d'impréparation** : préjudice moral du patient qui, faute d'information, n'a pas pu se préparer psychologiquement à un risque qui s'est réalisé.

Votre prochaine étape

Procurez-vous dès aujourd'hui un carnet dédié, inscrivez la date en tête de la première page et remplissez ce soir votre première fiche quotidienne. Le plus difficile est de commencer : à partir de demain, il ne s'agit plus que de continuer.

Un mot du cabinet

Tenir ce journal demande de la constance, dans une période où l'énergie manque souvent. Le cabinet LEXVOX AVOCATS, dédié au dommage corporel et à la responsabilité médicale, accompagne les victimes d'accident médical dans la construction de leur dossier. Une consultation initiale gratuite de 30 minutes permet de faire le point sur les éléments réunis et sur la façon de les valoriser. Vous pouvez joindre le standard au 04 90 54 58 10 ou nous retrouver sur <https://lexvox-victime.com>, dans nos quatre bureaux de Provence (Aix-en-Provence, Salon-de-Provence, Arles, Marignane).

Chemin : /home/user/lexvox-victime/kits/medical/palier-1/m1-3-journal-symptomes-sequelles.md Longueur approximative : 2 900 mots de texte rédigé, hors champs de saisie des modèles ; environ 8 pages une fois maquette avec les fiches quotidienne et hebdomadaire à remplir. Références citées (referentiel-verifie.json) : csp-L1111-2 (article L1111-2 du code de la santé publique, cité verbatim et par URL), cass-2014-12-22123-impreparation (Cass. 1re civ. 23 janvier 2014, n° 12-22.123, préjudice d'impréparation, cité verbatim et par URL), cass-2017-15-27898-impreparation (Cass. 1re civ. 25 janvier 2017, n° 15-27.898, confirmation, cité verbatim et par URL), dintilhac (nomenclature Dintilhac, outil de référence non normatif, cité pour les postes DFT, souffrances endurées et préjudice d'agrément). Preuves cabinet mobilisées : constat de pratique 2 à 5 fois, consultation gratuite de 30 minutes, coordonnées (BRIEF-REDACTION.md).